

Protocolo de Profilaxia de Tromboembolismo Venoso em Pacientes Internados

Hospital Cooperativo Serra Azul — Serra Azul (SC)

Identificador	PROT-005
Instituição	Hospital Cooperativo Serra Azul
Especialidade	clinica_medica
Versão	2
Vigência	2025-10-01
Próxima revisão	2027-10-01
Responsável técnico	Comissão de Protocolos Assistenciais
Situação	VIGENTE

1. Objetivo

Padronizar a avaliação de risco de tromboembolismo venoso e a indicação de profilaxia em pacientes adultos internados em unidades clínicas e cirúrgicas.

2. Momento da avaliação

A estratificação de risco é obrigatória em até 24 horas da admissão e deve ser repetida a cada 72 horas de internação, ou sempre que houver mudança relevante do quadro clínico, procedimento cirúrgico ou alteração da mobilidade.

3. Tabela de estratificação de risco

A pontuação total define a faixa de risco e a conduta correspondente.

Fator	Pontos
Idade igual ou superior a 60 anos	1
Mobilidade reduzida por mais de 72 horas	2
Episódio prévio de tromboembolismo venoso	3
Neoplasia ativa	3
Cirurgia de grande porte nos últimos 30 dias	2
Obesidade	1

Pontuação	Faixa de risco	Conduta
0 a 1	Baixo	Deambulação precoce e reavaliação em 72 h
2 a 3	Moderado	Profilaxia mecânica; avaliar farmacológica
4 ou mais	Alto	Profilaxia farmacológica salvo contraindicação

4. Contraindicações à profilaxia farmacológica

- Sangramento ativo clinicamente significativo.
- Plaquetopenia grave.

- Procedimento neuroaxial recente ou programado nas próximas horas.
- Hipersensibilidade conhecida ao agente considerado.

Na presença de contraindicação, indica-se profilaxia mecânica e registra-se o motivo em prontuário. Este protocolo não define agente, dose nem posologia; a prescrição é atribuição do médico assistente.

5. Fluxograma de decisão

O fluxograma de decisão resumido encontra-se no Anexo I deste documento e está afixado nos postos de enfermagem de todas as unidades de internação.

Anexo I — Fluxograma de decisão (descrição textual)

Admissão do paciente. Aplicar a tabela de estratificação em até 24 horas. Somar os pontos. Se a pontuação for de 0 a 1, orientar deambulação precoce e reavaliar em 72 horas. Se for de 2 a 3, iniciar profilaxia mecânica e avaliar indicação de profilaxia farmacológica. Se for 4 ou mais, verificar contraindicações; na ausência delas, indicar profilaxia farmacológica; na presença, indicar profilaxia mecânica e registrar o motivo. Em todos os casos, reavaliar a cada 72 horas.

Histórico de revisões

Versão	Data	Alteração
1	2022-11-30	Versão inicial.
2	2025-09-05	Inclusão da tabela de estratificação de risco e da reavaliação a cada 72 horas.

DOCUMENTO FICTÍCIO — gerado por software para demonstração técnica do projeto SCMedAI. Não é um protocolo clínico real, não foi validado por nenhuma instituição de saúde e NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ORIENTAR CUIDADO A PACIENTES.